

PTI — EXCLUIR OUTRAS CAUSAS + TRATAR

DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL DE PLAQUETOPENIA

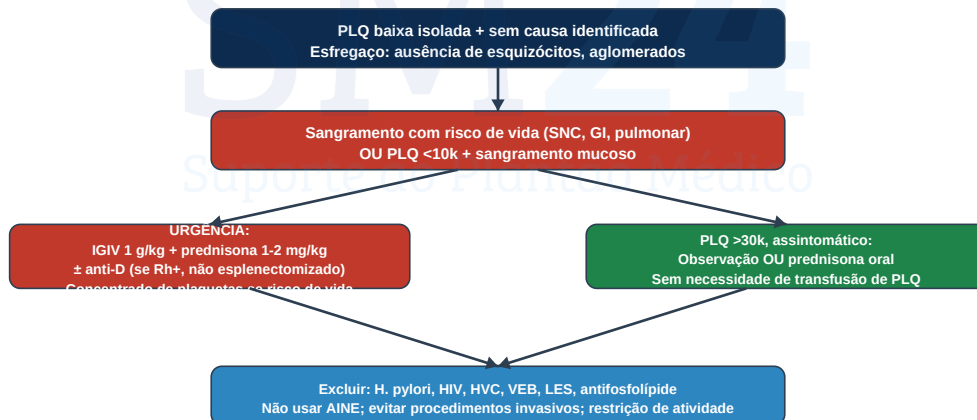
Causa	Pistas	Diferencial chave
PTI (imune)	Criança: pós-viral; adulto: crônico, mulher 20-40 anos; sem anemia hemolítica	Diagnóstico de exclusão: sem causa identificada
PTT (microangiopático)	Tríade: plaquetopenia + anemia hemolítica + sinais neurológicos — DEFICIÊNCIA ADAMTS13	Esquizócitos no esfregaço, LDH elevado, urgência
SHU	Criança: diarreia + E. coli O157:H7; adulto: atípico; IRA predominante	Esquizócitos + IRA + diarreia sanguinolenta
TAHIT tipo 2	Heparina há 5-14 dias + queda PLQ >50% + trombose	Anti-PF4 positivo, trombose paradoxal
Pseudoplaquetopenia	PLQ baixo em EDTA, normal em citrato	Repetir coleta em citrato; aglutininas
Drogas (quinidina, vancomicina, HBPM)	Temporal com início do medicamento	Suspender droga; recuperação em 7-10 dias

PTI — CLASSIFICAÇÃO E TRATAMENTO

Fase	Definição	Tratamento de escolha
Aguda	<3 meses de duração (maioria das crianças)	Corticoide ou IGIV; maioria resolve espontaneamente
Persistente	3-12 meses sem remissão espontânea	Corticoide + 2ª linha: rituximabe ou agonista de TPO
Crônica	>12 meses — maioria adultos; PLQ cronicamente <30k	Esplenectomia OU rituximabe OU agonistas TPO (eltrombopag, romiplostim)
Refratária	Sem resposta a esplenectomia + 2 outras linhas	Fostamatinibe, avatrombopag, incluir em ensaio clínico

MANEJO DA PTI AGUDA NO PS

PTI — SANGRAMENTO + PLAQUETAS



PTT — EMERGÊNCIA HEMATOLÓGICA

NÃO CONFUNDIR PTI COM PTT

- PTT: anemia hemolítica microangiopática + plaquetopenia + neurológico + renal + febre (pêntade)
- Esquizócitos no esfregaço: achado mais importante para diagnóstico
- Causa: deficiência de ADAMTS13 (hereditária ou anticorpo inibidor)
- NÃO transfundir plaquetas — agrava trombose microvascular
- TRATAMENTO: plasmaferese diária (PFC como fluido de reposição) URGENTE — início em <4h
- Adicionar rituximabe se anticorpo ADAMTS13 positivo (PTT imune)

CORTICOIDE E IGIV NA PTI

Prednisona

- Dose: 1-2 mg/kg/dia (máx 80 mg) VO por 2-4 semanas
- Resposta em 50-75% — mas maioria recidiva ao reduzir
- Dexametasona 40 mg/d × 4 dias: alternativa de pulso
- Efeitos adversos: hiperglicemia, HAS, osteoporose, úlcera
- Suplementar cálcio + vit D se uso >3 semanas
- Não usar por >3 meses (imunossupressão prolongada)

IGIV (Imunoglobulina IV)

- Dose: 1 g/kg/dia × 1-2 dias
- Resposta mais rápida que corticoide (72-96h)
- Mecanismo: bloqueio de receptores Fc dos macrófagos
- Indicação: sangramento grave, pré-procedimento urgente, PLQ <10k com síndrome hemorrágica
- Custo elevado; resposta temporária (semanas)
- Alternativa: anti-D 75 µg/kg (apenas RH+ não esplenectomizado)

WORKUP INICIAL DA PTI

NÃO PULAR

- ☐ Hemograma completo com reticulócitos e esfregaço do sangue periférico
- ☐ Coombs direto (excluir AIHA associada = síndrome de Evans)
- ☐ Sorologias: HIV, HCV, HBV, CMV, H. pylori (Ag fecal ou IgG)
- ☐ FAN/Anti-DNA: excluir LES como causa secundária
- ☐ Anticoagulante lúpico + anticardiolipina (síndrome antifosfolípide)
- ☐ Gravidez (beta-hCG): trombocitopenia gestacional ou PTI associada à gravidez

SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

FMUSP / Adaptada

Criança de 5 anos com petéquias difusas após infecção viral há 2 semanas. PLQ 8.000/ μ L, Hb 12 g/dL, leucócitos normais, esfregaço sem esquizócitos. Qual diagnóstico e conduta?

- A) PTT — plasmaferese urgente
- B) Leucemia — biópsia de medula óssea
- C) PTI aguda — corticoide e/ou IGIV; monitorar sangramento
- D) CIVD — crioprecipitado + PFC
- E) SHU — antibiótico para E. coli O157

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Adulta de 28 anos com PLQ 12.000/ μ L, anemia com Hb 7 g/dL, LDH 980, bilirrubinas elevadas e esquizócitos no esfregaço. Qual diagnóstico deve ser investigado IMEDIATAMENTE?

- A) PTI crônica — iniciar prednisona
- B) Aplasia medular — biópsia de medula
- C) PTT — plasmaferese urgente
- D) CIVD — PFC e crioprecipitado
- E) TAHIT — suspender heparina

QUESTÃO 3

CFM / Adaptada

Por que NÃO se deve transfundir plaquetas em paciente com PTT (Púrpura Trombocitopênica Trombótica)?

- A) Porque a transfusão não eleva as plaquetas nessa doença
- B) Porque as plaquetas transfundidas pioram a trombose microvascular — 'jogar combustível no fogo'
- C) Porque o custo é proibitivo
- D) Porque a maioria resolve espontaneamente em <24h
- E) Porque a transfusão de plaquetas causa aloimunização

QUESTÃO 4

SES-RJ / Adaptada

Qual é a terapia de primeira linha para PTI com PLQ <10k e sangramento oral ativo?

- A) Esplenectomia de urgência
- B) Prednisona isolada 1-2 mg/kg/dia
- C) IGIV 1 g/kg + prednisona (resposta rápida — IGIV eleva PLQ em 72-96h)
- D) Rituximabe 375 mg/m²
- E) Agonista de trombopoietina (eltrombopag)

QUESTÃO 5

UFMG / Adaptada

Por que H. pylori deve ser rastreado em pacientes com PTI?

- A) Porque H. pylori causa plaquetopenia por toxina direta
- B) Porque a erradicação do H. pylori melhora as plaquetas em 50-60% dos casos (mecanismo imune)
- C) Porque antibiótico tem efeito anti-inflamatório sobre plaquetas
- D) Porque H. pylori causa sangramento gástrico que confunde o diagnóstico
- E) Porque H. pylori é causa frequente de CIVD

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

PTI aguda pós-viral em criança: plaquetopenia isolada + sem causa identificada + sem esquizócitos + após infecção viral. PLQ 8.000 com petéquias = sintomático → corticoide (prednisona 1-2 mg/kg) e/ou IGIV. 80% resolvem espontaneamente em crianças. Monitorar sangramento grave.

QUESTÃO 2 → Resposta: C

PTT: anemia hemolítica microangiopática (esquizócitos + LDH elevado + Coombs negativo) + trombocitopenia. Urgência absoluta — plasmaferese em <4h reduz mortalidade de 90% para <15%. Transfusão de plaquetas é contraindicada (agrava microtrombose).

QUESTÃO 3 → Resposta: B

PTT: plaquetas consumidas por microtrombos de multímeros de VWF (sem ADAMTS13 para clivá-los). Transfundir plaquetas fornece substrato para mais trombose. Tratamento correto: plasmaferese (remove multímeros VWF e anticorpo ADAMTS13) + PFC (repõe ADAMTS13).

QUESTÃO 4 → Resposta: C

PTI com sangramento ativo + PLQ muito baixa: IGIV (1 g/kg) tem resposta mais rápida que prednisona (72-96h vs 5-7d). Associar prednisona para efeito mais prolongado. Transfundir PLQ somente em sangramento com risco de vida imediato (efeito temporário na PTI — destruição imune).

QUESTÃO 5 → Resposta: B

H. pylori estimula produção de anticorpos IgG que têm reatividade cruzada com antígenos plaquetários (molecular mimicry). Erradicação com amoxicilina + claritromicina + omeprazol (14 dias) melhora plaquetas em 50-60% dos casos de PTI H. pylori-positivo — deve ser sempre rastreado e tratado.

SM24
Suporte ao Plantão Médico